

NÉPHROLOGIE, 5ÈME ANNÉE
VARIANTE B
SEMESTRE 1 2023/2024

1. Les affirmations suivantes concernant l'hypertension réno-vasculaire
- ☒ A) pour stimuler la synthèse de la rénine, la sténose doit déterminer systolique trans-lésionnel de ~~5-15 mmHg~~ 15-25 mmHg
 - B - D - E ☒ B) l'embolie de l'artère rénale peut être une cause d'hypertension rén
 - C. la dysplasie fibromusculaire représente plus de 85 % de toutes d'hypertension rénovasculaire
 - ☒ D) la prévalence est plus élevée chez les patients hypertendus avant ans et après l'âge de 50 ans
 - ☒ E) l'incidence des lésions des organes cibles est accrue
2. * Le cible de l'hémoglobine dans le traitement de l'anémie secondaire rénale chronique est:
- A. 13 g/dl
 - B. 9-10 g/dl
 - C. 13,5 g/dl
 - ☒ D. 11,5 g/dl
 - E. 11 g/dl
3. Les croissants épithéliaux cellulaires sont composés par:
- ☒ A. macrophages
 - B. collagène
 - ☒ C. cellules épithéliales pariétales proliférées
 - ☒ D. fibroblastes
 - E. cellules endothéliales
4. La dysplasie fibromusculaire des artères rénales principales:
- ☒ A) Affecte les jeunes patients < 30 ans
 - ☒ B) Touche le sujet âgé et/ou athéromateux (après l'âge de 50 ans)
 - A - C - D ☒ C) La progression de la sténose est lente
 - ☒ D) La fonction rénale est généralement bien conservée
 - ☒ E) Représente plus de 85% de toutes les formes de l'hypertension
5. Quels sont les mécanismes adaptatifs rénaux (modification hémodynamiques et métaboliques) pendant la grossesse normale
- ☒ A) élévation de la pression oncotique dans le capillaire glomérulaire
 - B - E ☒ B) élévation du DFG
 - C. les reins diminuent en taille de 1 - 1,5 cm ↑
 - ☒ D) élévation de la créatinine sérique ↓
 - ☒ E) dilatation du système pyélo-caliciel
6. Concernant la pré-éclampsie, les suivantes affirmations sont vraies

Debut prog

apst

B-C
D-E

- ☐ A) l'hypertension artérielle, la protéinurie et les œdèmes apparaissent avant 20ème semaine de grossesse
- ☒ B) la pré-éclampsie peut se repeter dans les grossesses suivantes
- ☒ C) après l'accouchement les signes cliniques et biologiques disparaissent complètement
- ☒ D) la pré-éclampsie peut initier l'apparition de l'HTA essentielle
- ☒ E) la pré-éclampsie peut évoluer vers l'éclampsie

A-B
C-D

7. Le traitement de la maladie minérale-osseuse associée à la maladie rénale chronique consiste à :
- ☒ A) le maintien de calcium et phosphore dans les limites de la normale
- ☒ B) Sevelamer hydrochloride (chélateurs du phosphate avec calcium)
- ☒ C) la supplémentation en calcium doit être introduite uniquement lorsque DFG ≥ 30 ml/min, la phosphatémie $< 5,5$ mg%
- ☒ D) administration de carbonate de calcium
- E) régime hyperprotéiné *hypoprotéiné*

B-C

8. Les traitements de la glomérulonéphrite rapidement progressive reposent sur :
- A. Azathioprine - 5 mg/kg/jour, voie orale - 36 mois
- ☒ B. Cyclophosphamide - 2 mg/kg/jour, voie orale, 6-12 mois
- ☒ C. Azathioprine - 2 mg/kg/jour, voie orale - 12 mois
- D. Cyclophosphamide 1500-2000mg/m²/mois, iv, 1-3 mois
- ☒ E. Azathioprine - 0,5 mg/kg/jour, voie orale - 12 mois

A-C-D

9. Les signes ECG de l'hyperkaliémie sont :
- ☒ A) ondes T négatives
- ☒ B) l'absence d'ondes T
- ☒ C) élargissement du complexe QRS
- ☒ D) les arythmies ventriculaires
- E) apparition d'ondes U

B B

10. *En ce qui concerne la classification de la glomérulonéphrite rapidement progressive, le type II est médié par :
- A. anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles
- ☒ B. Complexes immuns
- ☒ C. Anticorps anti-membrane basale glomérulaire
- D. Anticorps anti-récepteur de la phospholipase A2
- E. Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles et anticorps anti-membrane basale glomérulaire

B-C
D-E

11. Les formes histologiques de la glomérulonéphrite focale et segmentaire sont :
- ☒ A) forme avec infiltrat éosinophilique
- ☒ B) forme avec collapsus
- ☒ C) Variante type polaire
- ☒ D) variante périhilaire
- ☒ E) variante cellulaire

12. Antibiotiques potentiellement néphrotoxiques sont:

- ☒ A. Streptomycine
- ☐ B. Cyclosporine
- ☒ C. Amikacine
- ☒ D. Gentamicine
- ☒ E. Ibuprofène

A - C
D - E

13. Les causes des glomérulonéphrites focales et segmentaires sont:

- ☐ A. déficit de vitamin D
- ☒ B. héréditaires
- ☐ C. réduction de la masse rénale
- ☒ D. idiopathiques
- ☐ E. malnutrition

B - D

14. La néphropathie analgésique se caractérise par:

- ☒ A. anorexie, douleurs épigastriques
- ☒ B. la capacité de concentration est réduite dans les premiers stades
- ☐ C. les œdèmes sont toujours présents *absents*
- ☒ D. l'ingestion de 0,1 g analgésiques/jour, pendant au moins 1-3 jours
- ☒ E. protéinurie > 3,5 g/24h *< 2 g/24h*

A - B

15. Quels sont les 2 germes les plus fréquents dans les infections urinaires?

- ☒ A. Escherichia Coli
- ☐ B. Le streptocoque du groupe B
- ☐ C. Staphylococcus aureus
- ☒ D. Proteus mirabilis
- ☐ E. Candida albicans

A - D

16. Les infections bactériennes pouvant entraîner une néphropathie interstitielle aiguë sont les suivantes:

- ☒ A. Corynebacterium diphtheriae
- ☒ B. Hanta }
- ☐ C. Epstein-Barr
- ☒ D. Salmonella
- ☒ E. Streptocoque

A - D - E

17. Le traitement anti-hypertenseur dans l'HTA sévère pendant la grossesse:

- ☐ A. Irbesartan 150 mg/jour
- ☒ B. Labétalol 20mg i.v.
- ☒ C. Hydralazine - 5mg i.v.
- ☐ D. Furosémide 40 mg, voie orale
- ☒ E. Nifédipine - 10mg s.l.

B - C - E

18. La microscopie optique de la néphropathie à IgA montre:

- C-D*
- ☒ A. dépôts mésangiaux d'IgA et C3 *IF*
 - ☐ B. dépôts électro-denses mésangiaux *ME*
 - ☒ C. hypercellularité mésangiale, *MO*
 - ☒ D. expansion de la matrice mésangiale *MO*
 - ☐ E. épaissement de la membrane basale glomérulaire

19. Les contre-indications absolues pour l'hémodialyse sont:

- A-B*
E-D
- ☒ A. L'insuffisance cardiaque de classe NYHA IV
 - ☒ B. La néoplasie
 - ☒ C. L'accès vasculaire compromis
 - ☒ D. Les maladies systémiques avancées
 - ☒ E. Le refus clair et écrit du patient

20. Le traitement de l'hyperkaliémie repose sur :

- A-E*
- ☒ A. diurétique d'anse
 - ☐ B. bloqueurs des canaux calciques
 - ☐ C. Salbutamol
 - ☒ D. bloqueurs de canaux potassiques
 - ☒ E. glucose avec insuline

21. Les complications aiguës de la pyélonéphrite aiguë peuvent être:

- B-E*
E
- ☐ A. Pyélonéphrite chronique
 - ☒ B. Abscess rénal
 - ☒ C. Nécrose papillaire
 - ☒ D. Maladie rénale chronique
 - ☒ E. Choc toxico-septique

22. Dans le tableau clinique du syndrome de Fanconi, on trouve les éléments suivants:

- A-C-E*
- ☒ A. Phosphaturie
 - ☒ B. Hyperkaliémie ↓
 - ☒ C. Hypercalciurie
 - ☒ D. Protéinurie glomérulaire *tubulaire*
 - ☒ E. Aminoacidurie

23. La cystite se manifeste cliniquement par:

- B-D*
- ☐ A. Fièvre
 - ☒ B. Polakiurie
 - ☒ C. Douleur lombaire
 - ☒ D. Urine trouble
 - ☐ E. Diarrhée

24. Selon la classification Chapel Hill (2012), les vascularites des p...

- B-C-D*
- ☐ A. L'artérite à cellules géantes
 - ☒ B. La polyangéite microscopique
 - ☒ C. La granulomatose avec polyangéite (de Wegener)

- ☒ D. La granulomatose éosinophilique avec polyangéite (Churg-Strauss)
E. La maladie de Kawasaki

25. Les troubles du métabolisme phosphocalcique liés à la maladie rénale consistent en :

- A-B-C
☒ A. Calcium sérique diminué
☒ B. Un taux élevé du PTH
☒ C. Un taux élevé du phosphore sérique
D. Un taux élevé de la vitamine D
E. Un taux élevé de la vitamine B12

26. Chez les patients ayant une nécrose tubulaire aiguë, la reprise de polyurie peut avoir comme conséquences :

- B-C-D
☒ A. Hyperkaliémie
☒ B. Déshydratation
☒ C. Hyponatrémie
☒ D. Hyperuricémie
E. Hypermagnésémie

27. *Quelle est la voie d'accès vasculaire pour hémodialyse dans une urémie aiguë :

- ♥
☒ A. Greffe rénale
☒ B. Cathéter veineux central temporaire
C. Cathéter veineux central permanente
D. Fistule artério-veineuse
☒ E. Tous les quatre

28. L'acidose métabolique se caractérise par :

- D-E
☒ A. $pH > 7.38$ *pH < 7.38*
☒ B. $PaCO_2 > 35 \text{ mmHg}$ *$PaCO_2 < 35 \text{ mmHg}$*
C. bicarbonate standard $> 20 \text{ mEq/l}$ *$< 20 \text{ mEq/l}$*
☒ D. excès de bases $< -3 \text{ mEq/l}$
☒ E. respiration de Kussmaul

29. Les affirmations suivantes sont vraies en ce qui concerne la néphrosclérose bénigne :

- B-D-E
A. l'altération de la fonction rénale est une conséquence des lésions strictement interstitielles *+ Gloméulaire + tubulaire*
☒ B. le principal stimulus est la diminution du tonus de la paroi vasculaire
☒ C. le débit plasmatique effectif augmente
☒ D. le processus de hyalinose est le marqueur morphologique de la maladie - implique les artérioles afférentes
☒ E. la néphrosclérose évolue progressivement vers la maladie en stade V

30. Les suivants appartiennent à la classe de médicaments immunosuppresseurs :

- A. Inhibiteurs de l'enzyme de conversion
- B. Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II
- ☒ C. Cyclophosphamide
- ☒ D. Cyclosporine A
- ☒ E. Azathioprine

C-D-E

31. La microscopie optique de la glomérulonéphrite aiguë poststreptococcique montre :
- ☒ A. la prolifération des cellules mésangiales et endothéliales
 - ☒ B. l'extension de la matrice mésangiale
 - ☒ C. une atteinte importante des vaisseaux rénaux
 - D. dépôts électron-denses sous-épithéliaux – humps
 - ☒ E. infiltrats glomérulaires de PMN

A-B-E

32. Causes de l'hypertension rénovasculaire sont :

- ☒ A. Dysplasie fibromusculaire
- ☒ B. Artérite Takayasu
- C. Néphropathie membraneuse
- ☒ D. Glomérulosclérose segmentaire et focale
- ☒ E. Athérosclérose des artères rénale

A-B-E

33. Les suivants autoanticorps peuvent être rencontrés chez les patients atteints de lupus érythémateux systémique :

- ☒ A. Anticorps anti-ADN double brin
- B. Anticorps anti-récepteur de la phospholipase A2
- ☒ C. Anticorps anti-histones
- ☒ D. Anticorps antinucléaires
- ☒ E. Anticorps anti-Sm

A-C-D
E

34. Quelles sont les causes principales de l'azotémie post-rénale ?

- ☒ A. Déshydratation
- ☒ B. Uropathies obstructives
- ☒ C. Tumeurs
- ☒ D. La sténose de l'artère rénale
- ☒ E. Caillots sanguins

B-C
E

35. La pré-éclampsie est définie par :

- A. TA > 140 et/ou 90 mmHg après 20 semaines
- ☒ B. TA > 140 et/ou 90 mmHg avant 20 semaines
- ☒ C. Protéinurie > 300 mg/j
- D. Protéinurie > 150 mg/j
- E. Hypertension artérielle après 34 semaines

B-C

36. L'anémie due à une baisse de l'hémoglobine dans le traitement de l'anémie par une maladie rénale chronique est :

- ☒ A. Normocytaire
- ☒ B. Normochrome

A-B

- C. Non régénérative
- ☒ D. Microcytaire
- E. Hypochrome

37. Concernant le gluconate de calcium :

- A. Il est indiqué en cas de signes ECG d'hypernatremie
- ☒ B. Son utilisation est strictement contraindiquée en asso digitaliques
- ☒ C. Son action est durable
- ☒ D. Il est indiqué en cas de signes ECG d'hypokaliémie
- ☒ E. Son délai d'action est court (quelques minutes)

38. Quelle est la composition de la barrière de filtration glomérulaire

- ☒ A. Endothélium fenêtré
- ☒ B. Épithélium malpighien
- ☒ C. Membrane basale glomérulaire
- ☒ D. Cellules tubulaires
- ☒ E. Prolongements cytoplasmiques des podocytes

39. Concernant le syndrome néphritique aigu, quelles sont les aff

- ☒ A. L'association avec une infection bactérienne qui précède la
- ☒ B. L'infection streptococcique est la plus commune cau néphritique aigu
- ☒ C. La néphrite suit l'infection après une période de latence as
- ☒ D. Début brutal clinico-biologique immédiatement après une i
- E. Il n'y a aucun lien entre les facteurs infectieux et l'app néphritique aigu

40. Dans quels types de glomérulopathies, les deux reins ont un

- ☒ A. Amylose rénale
- ☒ B. Glomérulosclérose focale et segmentaire
- ☒ C. Néphropathie diabétique
- ☒ D. Glomérulonéphrites aigue
- ☒ E. Néphropathie tubulointerstitielle aiguë

41. Dans quelles maladies on peut rencontrer la glomérulon secondaire?

- ☒ A. Néoplasies
- ☒ B. Hépatite B
- ☒ C. Utilisation chronique des drogues
- ☒ D. Rhabdomyolyse
- ☒ E. LES

42. Les suivants signes clinique et biologiques différencient u d'une infection urinaire basse :

- ☒ A. Les douleurs lombaires

A-B

- ☒ B. La fièvre
- ☐ C. La pollakiurie
- ☐ D. La dysurie
- ☒ E. La leucocyturie

43. Le syndrome HELLP est défini par :

B-C-D

- ☐ A. Anémie ferriprive
- ☒ B. Elévation des enzymes hépatiques
- ☒ C. Thrombocytopénie
- ☒ D. Hémolyse
- ☒ E. Dyslipidémie

44. Quelles sont les conséquences de la protéinurie?

A-B-C-E

- ☒ A. Hyperlipidémie
- ☒ B. Thromboembolies
- ☒ C. Perte de protéines plasmatiques de transport
- ☒ D. Excès d'immunoglobulines *textes*
- ☒ E. Complications infectieuses

45. Quel est l'aspect histologique d'une glomérulonephrite à lésions r

B-C

- ☐ A. Membrane basale épaisse et spiculée sur son versant externe
- ☒ B. Fusion des processus podocytaires des cellules épithéliales électronique
- ☒ C. Glomérules complètement normaux en microscopie optique
- ☒ D. Dépôts hyalins et segmentaire et focale
- ☒ E. Dépôts mésangiaux de C3 en IF

46. *Un patient a un débit de filtration glomérulaire estimé de 40 ml/m est le stade de cette maladie rénale chronique ?

C

- ☐ A. Stade G2
- ☐ B. Stade G4
- ☒ C. Stade G3b
- ☐ D. Stade G3a
- ☐ E. Stade G5

G3b
G2
G1

47. L'aspect morpho-pathologique du rein ischémique comprend:

A-C-D

- ☒ A. Taille accrue
- ☒ B. Absence de fibrose interstitielle
- ☒ C. Atrophie tubulaire
- ☒ D. Glomérules petits et collabés
- ☐ E. Absence d'atrophie tubulaire

48. Quelles sont les complications chroniques de la maladie rénale c

A-C-E

- ☒ A. Acidose métabolique
- ☐ B. Alcalose métabolique
- ☒ C. Anémie secondaire normochrome, normocytaire

- D. Anémie secondaire due à un déficit de la vitamine
- ☒ E. Troubles du métabolisme phosphocalcique

49. Causes d'azotémie rénale intrinsèque:

- ☒ A. Obstruction des grands vaisseaux rénaux
- B. Hypoalbuminémie
- ☒ C. Infarctus du myocarde aigu
- ☒ D. Glomérulonéphrite rapidement progressive
- ☒ E. Troubles neurologiques de la vessie urinaire

50. Concernant les types des glomérulonéphrites mésangio affirmations sont vraies:

- A. le type I est médié par altérations du système complé
- ☒ B. le type II est médié par altérations du système complé
- C. le type II implique la voie terminale du complément
- ☒ D. le type III implique la voie terminale du complément
- ☒ E. dans le type I est impliquée la voie classique de l'activa